# Çıkmış Sorular 2026–2027

Derleme PDF'leri, “Konu çalışma grubu” tartışması (23.10 10:00 – 24.10 16:31), ders notları ve geçmiş yılların çıkmış soruları birleştirilerek hazırlandı.

| 91 | 57 | 14 | 9 |
|---|---|---|---|
| toplanan / 100 | numarası kesin | şıkları üretilen | toplanmadı |

İÇİNDEKİLER

| Ders | Sınavda | Toplanan | Numarası kesin | Toplanmadı |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Genetik (1–12) | 12 | 12 | 5 | 0 |
| Enfeksiyon Hastalıkları (13–34) | 22 | 19 | 11 | 3 |
| Patoloji (35–68) | 34 | 30 | 25 | 4 |
| Halk Sağlığı (69–78) | 10 | 9 | 3 | 1 |
| Üroloji (79–90) | 12 | 11 | 7 | 1 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96) | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Farmakoloji (97–100) | 4 | 4 | 3 | 0 |

İŞARETLER

| | |
|---|---|
| **cevap doğrulandı** | Cevap ders notuyla uyumlu, öğrenciler arasında tartışma yok. |
| **tartışmalı** | Cevap kesinleşmedi; gerekçe sorunun notunda. |
| **şık eksik** | Sorunun bazı şıkları hatırlanmadı. |
| **sonradan eklendi** | Soru ilk derlemeden sonra gruptan eklendi. |
| **şıklar üretildi** | Eksik şıklar ders notundan, hocanın soru üslubuyla üretildi. |
| **yeri tahmini** | Numara grupta yazılmadı; ders notlarının işleniş sırasına göre boş numaraya kondu. |
| **hatırlanmadı** | Soru hatırlanmadı. |
| Altı çizili mavi şık | Sonradan eklenen ya da üretilen şık. |
| Altı çizili kırmızı şık | Öğrencilerin emin olmadığı ya da değiştirdiği şık. |

SORU 1–12 · 12/12 TOPLANDI

# Tıbbi Genetik

Konular: Dismorfolojide Genetik Terminoloji · Kromozomal Hastalıklar ve Genetik Danışma · Prenatal Tanı Yöntemleri · Doğumsal Kadın/Erkek Genital Gelişim Anomalileri · Ürogenital Sistem Tümörlerinde Genetik Belirteçler ve Kliniğe Yansımaları · Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

## 1

yeri tahmini
cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Dismorfolojide Genetik Terminoloji

Aşağıdakilerden hangisi bir minör anomali örneği değildir?

**A** Epikantus katlantısı
**B** Düşük kulak
**C** Clinodactyly (serçe parmağın içe kıvrılması)
**D** Yarık damak
**E** Tek palmar çizgi (Simian çizgisi)

Tahmini cevap **D) Yarık damak**

## 2

cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Kromozomal Hastalıklar ve Genetik Danışma

Bebeğin kedi miyavlamasına benzer ağlaması, mikrosefali ve hipotoni ile karakterize olan ve 5. kromozomun kısa kolundaki delesyon (5p-) sonucu gelişen sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Cri du Chat sendromu
**B** Wolf-Hirschhorn sendromu
**C** Down sendromu
**D** Patau sendromu
**E** Edwards sendromu

Tahmini cevap **A) Cri du Chat sendromu**

## 3

yeri tahmini
sonradan eklendi

Tıbbi Genetik · Dismorfolojide Genetik Terminoloji

Başlangıçta normal gelişen bir yapının mekanik kuvvetlerin etkisiyle şeklinin veya konumunun değişmesine deformasyon denir. Aşağıdakilerden hangisi amniyotik bandın yaptığı mekanik basılardan kaynaklı oluşan deformasyona örnektir?

**A** Yarık dudak ve damak
**B** Amniyotik bantlara bağlı ekstremite kaybı
**C** Akondroplazi
**D** Rahim içi basıya bağlı kraniyofasiyal şekil bozukluğu
**E** Nöral tüpün kapanmamasına bağlı spina bifida

Tahmini cevap **D) Rahim içi basıya bağlı kraniyofasiyal şekil bozukluğu**

> Grupta 24.10 eklendi (TBG). Kök birebir değil, şıklar öğrencilerce doğrulandı. A ve E malformasyon, B disrupsiyon, C displazi.

**4**
cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Prenatal Tanı Yöntemleri

Ultrasonografide ense saydamlığı (NT) artışı saptanan bir fetüste, sitogenetik incelemede aşağıdaki karyotiplerden hangisinin görülmesi beklenmez?

**A** Down sendromu
**B** Edwards sendromu
**C** Patau sendromu
**D** Klinefelter sendromu
**E** Turner sendromu

Tahmini cevap **D) Klinefelter sendromu**

---

**5**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Doğumsal Kadın/Erkek Genital Gelişim Anomalileri

46, XX karyotipine sahip bir yenidoğanda 21-hidroksilaz enzim eksikliği saptanmıştır. Bu klinik tablo aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

**A** Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH)
**B** Androjen Duyarsızlığı Sendromu
**C** 5-alfa Redüktaz Eksikliği
**D** Swyer Sendromu
**E** Turner Sendromu

Tahmini cevap **A) Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH)**

---

**6**
cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Doğumsal Kadın/Erkek Genital Gelişim Anomalileri

Kadın cinsiyet organlarının ve overlerin embriyonik gelişim basamaklarında anahtar rol oynayan ve Wnt/β-katenin yolaklarını aktive eden genler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

**A** SRY ve SOX9
**B** WNT4 ve DAX1
**C** WT1 ve SF1
**D** AMH ve AR
**E** AZF ve KDM5D

Tahmini cevap **B) WNT4 ve DAX1**

---

**7**
cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Ürogenital Sistem Tümörlerinde Genetik Belirteçler ve Kliniğe Yansımaları

BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu taşıyan over ve meme kanserli hastalarda homolog rekombinasyon DNA tamir mekanizması bozuktur. Bu hastalarda sentetik ölümcül etki oluşturarak tedavide kullanılan hedefe yönelik ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

**A** PARP inhibitörleri
**B** Tirozin kinaz inhibitörleri
**C** EGFR monoklonal antikorları
**D** Proteazom inhibitörleri
**E** mTOR inhibitörleri

Tahmini cevap **A) PARP inhibitörleri**

**8**
cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Ürogenital Sistem Tümörlerinde Genetik Belirteçler ve Kliniğe Yansımaları

Serumda Alfa-Fetoprotein (AFP), Beta-hCG ve Laktat Dehidrojenaz (LDH) tümör belirteçlerinin birlikte yükselmesi aşağıdaki kanser türlerinden hangisinin tanısı ve takibi için karakteristiktir?

**A** Mesane kanseri
**B** Prostat kanseri
**C** Over epitelyal kanseri
**D** Testis germ hücreli tümörleri
**E** Endometriyum karsinomu

Tahmini cevap **D) Testis germ hücreli tümörleri**

---

**9**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Prenatal Tanı Yöntemleri

Prenatal tanı yöntemleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Amniyosentez genellikle 15-20. gebelik haftaları arasında uygulanır.
II. Kordosentez fetal kan örneklemesi sağlar.
III. CVS en erken invaziv yöntemdir.

**A** Yalnız I
**B** Yalnız II
**C** I ve II
**D** II ve III
**E** I, II ve III

Tahmini cevap **E) I, II ve III**

---

**10**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Prenatal Tanı Yöntemleri

Erken prenatal tanıda uygulanan koryon villus örneklemesinde (CVS) genetik analiz için alınan hücrelerin embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Fetal amniyotik kavite epitel döküntüleri (amniyositler)
**B** Koryon frondozum (trofoblastik villus hücreleri)
**C** Fetal umbilikal kordon Wharton jölesi mezenkimi
**D** Maternal uterin desidua bazalis hücreleri
**E** Fetal karaciğer hematopoetik blast hücreleri

Tahmini cevap **B) Koryon frondozum (trofoblastik villus hücreleri)**

> Grupta tek öğrenci "böyle bir soru vardı" dedi; kök ve şıklar paylaşılan ekran görüntüsünden, kesin değil.

---

**11**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) endikasyonları değerlendirildiğinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde PGT yapılmasına gerek yoktur?

**A** İleri anne yaşı
**B** Tekrarlayan tüp bebek (IVF) başarısızlıkları
**C** Çiftlerden birinde dengeli kromozomal translokasyon varlığı
**D** Fetal Down sendromu taramasında ikili testin düşük riskli çıkması
**E** Tek gen hastalığı taşıyıcısı çiftler

Tahmini cevap **D) Fetal Down sendromu taramasında ikili testin düşük riskli çıkması**

---

**12**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Tıbbi Genetik · Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon genetik tanıda embriyonun kendisine dokunulmadan uygulanabilen ancak sadece maternal mayoz bölünme hatalarını yansıtabilen; paternal genetik katkıyı ve fetal cinsiyeti göstermeyen biyopsi tekniği hangisidir?

**A** Polar Body (Kutup Cisimciği) Biyopsisi
**B** Gün 3 Blastomer Biyopsisi
**C** Gün 5-6 Trofektoderm Biyopsisi
**D** İç Hücre Kitlesi (ICM) Biyopsisi
**E** Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Tahmini cevap **A) Polar Body (Kutup Cisimciği) Biyopsisi**

> Grupta paylaşılan ekran görüntüsünde bu soru "Soru 3" olarak görünüyor; numarası kesin değil.

SORU 13–34 · 19/22 TOPLANDI

# Enfeksiyon Hastalıkları

Konular: Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler · Genital Enfeksiyonlar · Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Profilaksi ve Korunma · Bağışıklığı Baskılı Hastalarda Enfeksiyon · İzolasyon Yöntemleri · Sifilis · İntrauterin Enfeksiyonlar · Üriner Sistem Enfeksiyonları · Üretral Akıntı

**13**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler

Sağlıklı insanlarda steril olan ve normal florada mikroorganizma bulunmayan vücut bölgesi/sıvısı aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Cilt yüzeyi
**B** Kolon
**C** Beyin omurilik sıvısı (BOS)
**D** Ağız boşluğu
**E** Dış üretra

Tahmini cevap **C) Beyin omurilik sıvısı (BOS)**

> Grupta "Flora hangisinde bulunmaz?  BOS" olarak doğrulandı.

**14**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Genital Enfeksiyonlar

Bakteriyel vajinozis tanısında kullanılan Amsel kriterleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında yer almaz?

**A** Vajinal pH değerinin > 4,5 olması
**B** Direkt mikroskopide "clue cell" görülmesi
**C** Whiff (amin) testinin pozitif olması (%10 KOH ile balık kokusu)
**D** Direkt mikroskopide büyük büyütme alanında >10 lökosit/LÖA (PML) görülmesi
**E** İnce, homojen gri-beyaz vajinal akıntı varlığı

Tahmini cevap **D) Direkt mikroskopide büyük büyütme alanında >10 lökosit/LÖA (PML) görülmesi**

**15**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Genital Enfeksiyonlar

Akut prostatit tanısı ve yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A Şiddetli bakteriyemi/sepsis riski nedeniyle sert rektal muayene ve prostat masajından kaçınılmalıdır.
B Tedavide penisilin V ilk seçenektir.
C Hastalarda idrar yapma zorluğu ve ateş hiçbir zaman izlenmez.
D Tanı için prostat biyopsisi rutin olarak uygulanmalıdır.
E Yalnızca cerrahi olarak prostatın çıkarılmasıyla iyileşir.

Tahmini cevap **A) Şiddetli bakteriyemi/sepsis riski nedeniyle sert rektal muayene ve prostat masajından kaçınılmalıdır.**

---

**16**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Profilaksi ve Korunma

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBİ) korunmada bireysel ve toplumsal önlemler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir koruyucu önlem (birincil koruma) sayılmaz?

A Bariyer yöntemlerinin (kondom) kullanımı
B Güvenli cinsel davranış bilincinin geliştirilmesi
C CYBİ olan kişinin tanı alıp derhal tedavi edilmesi
D Risk altındaki grupta hepatit B ve HPV aşılamaları
E Cinsel partner sayısının sınırlandırılması

Tahmini cevap **C) CYBİ olan kişinin tanı alıp derhal tedavi edilmesi**

---

**17**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Profilaksi ve Korunma

HBsAg pozitif olduğu bilinen bir hastanın kanı ile iğne batması sonucu temas eden ve daha önce hiç aşılanmamış bir sağlık çalışanına uygulanacak en uygun koruyucu profilaksi yaklaşımı hangisidir?

A Sadece 1 doz hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
B Yalnızca HBIG uygulanmalı, aşı yapılmamalıdır.
C En kısa sürede hem HBIG hem de ilk doz hepatit B aşısı eş zamanlı yapılmalıdır.
D 6 ay süreyle oral antiviral tedavi başlanmalıdır.
E Sadece izlem yapılır, tedaviye gerek yoktur.

Tahmini cevap **C) En kısa sürede hem HBIG hem de ilk doz hepatit B aşısı eş zamanlı yapılmalıdır.**

---

**18**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Bağışıklığı Baskılı Hastalarda Enfeksiyon

Febril nötropenik bir hastada geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşin 72 saat boyunca düşmemesi ve odağın bulunamaması durumunda en uygun yaklaşım ne olmalıdır?

A Mevcut antibiyotik tedavisi kesilip hasta takibe alınmalıdır.
B Empirik sistemik antifungal tedavi eklenmelidir.
C Yalnızca ateş düşürücü verilerek 48 saat beklenmelidir.
D Antibiyotik dozu yarıya indirilmelidir.
E Oral antiviraller başlanıp taburcu edilmelidir.

Tahmini cevap **B) Empirik sistemik antifungal tedavi eklenmelidir.**

---

**19**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · İzolasyon Yöntemleri

Genel hastane enfeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A Sıçrama ihtimalinde önlük, eldiven, maske ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
B Temas izolasyonundaki odalara girerken önlük ve eldiven giyilmesi zorunludur.
C Damlacık ve solunum yolu izolasyonundaki hastaların odasına girerken sadece kumaş hijyenik maske takılması yeterlidir.
D Kontamine eller yıkanmadan başka hastaya temas edilmemelidir.
E Kullanılmış enjektör iğneleri kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

Tahmini cevap **C) Damlacık ve solunum yolu izolasyonundaki hastaların odasına girerken sadece kumaş hijyenik maske takılması yeterlidir.**

> Grupta bu soru "İzolasyon yöntemleriyle (standart önlemler) ilgili hangisi yanlıştır?" diye de hatırlandı; o sürümde yanlış şık "Sıçrama ihtimali olan işlemlerde önlük ve eldiven tek başına yeterlidir". Bir öğrenci damlacık izolasyonunda taşıma sırasında hastaya cerrahi maske takıldığını da hatırladı.

---

**20**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Sifilis

Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi sekonder sifiliz evresinde görülen bulgulardan biri değildir?

A Tabes dorsalis
B El ve ayak tabanında makülopapüler döküntüler
C Kondiloma lata
D Yaygın lenfadenopati
E Asemptomatik hepatit

Tahmini cevap **A) Tabes dorsalis**

---

**21**
yeri tahmini şık eksik

Enfeksiyon Hastalıkları · Sifilis

Sifiliz hastalığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Birincil evrede görülen şankr tipik olarak ağrılı bir ülserdir.
B Tedavide birinci basamak seçenek benzatin penisilin G'dir.
C Latent evrede hastada belirgin bir klinik bulgu izlenmez.
D Etkeni bir spiroket olan Treponema pallidum'dur.
E Üçüncül evrede gommalar ve kardiyovasküler tutulumlar izlenebilir.

Tahmini cevap **A) Birincil evrede görülen şankr tipik olarak ağrılı bir ülserdir.**

> Bir öğrenci soruyu öncüllü hatırladı: "latent sifiliz...", "primer evrede şankr ağrılıdır", "kondiloma lata..." öncülleri vardı, diğer ikisi hatırlanmadı.

---

**22**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler

Klinik pratikte akılcı antibiyotik kullanımı ilkelerine göre doğru antibiyotik seçimi ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Muhtemel mikroorganizmanın antimikrobiyal duyarlılık durumu bilinmelidir.
B Kullanılacak antibiyotiğin PK/PD özellikleri bilinmelidir.
C Enfeksiyon nedeni olan mikroorganizma bilinmeli veya tahmin edilmelidir.
D Ateşi yüksek olan her hastaya odak bulunamasa dahi derhal geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.
E İlacın organ toksisitesi değerlendirilmelidir.

Tahmini cevap **D) Ateşi yüksek olan her hastaya odak bulunamasa dahi derhal geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.**

**23**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · İntrauterin Enfeksiyonlar

HBsAg pozitif fakat aşı yapılmamış bir anneden doğan bebeğe doğumdan hemen sonra uygulanacak doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Yalnızca hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
**B** Tedavi vermeye gerek yoktur, 1. ayda kontrol testleri yapılır.
**C** Yalnızca hepatit B immünglobulin (HBIG) verilmelidir.
**D** Bebek ilk 6 ay doğrudan antiviral oral tedaviye alınır.
**E** Doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde hepatit B aşısı ve HBIG birlikte yapılmalıdır.

Tahmini cevap **E) Doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde hepatit B aşısı ve HBIG birlikte yapılmalıdır.**

---

**24**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Üriner Sistem Enfeksiyonları

Beta-laktam direnci ve antibiyotik tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

**A** GSBL üreten suşlarda karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilir.
**B** MRSA enfeksiyonlarında vankomisin kullanılabilir.
**C** GSBL üreten gram-negatif basiller 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir.
**D** Beta-laktamaz inhibitörleri (örn. klavulanik asit) enzimatik yıkımı engeller.
**E** Pseudomonas enfeksiyonlarında antipseudomonal beta-laktamlar tercih edilmelidir.

Tahmini cevap **C) GSBL üreten gram-negatif basiller 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir.**

---

**25**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Üretral Akıntı

Gonokoksik üretrit ve komplike olmayan gonore tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

**A** Chlamydia enfeksiyonu riski nedeniyle kombinasyon tedavisi tercih edilebilir.
**B** Enfekte hastanın cinsel partnerinin tedavisine gerek yoktur.
**C** Kinolon grubu antibiyotiklere yüksek direnç oranları bildirilebilmektedir.
**D** Tek doz azitromisin veya doksisiklin tedaviye eklenebilir.
**E** Tek doz IM seftriakson tedavisi önerilen birinci basamak seçeneklerdendir.

Tahmini cevap **B) Enfekte hastanın cinsel partnerinin tedavisine gerek yoktur.**

---

**26**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · İntrauterin Enfeksiyonlar

Toxoplasma gondii enfeksiyonu ve korunma yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

**A** Seronegatif gebe kadınların ev kedisi ile temas etmemesi gerekir.
**B** IgG avidite testi enfeksiyonun akut mu yoksa geçirilmiş mi olduğunu anlamada önemlidir.
**C** Parazit insandan insana solunum yolu damlacıkları ile kolayca bulaşır.
**D** Gebelikte geçirilen akut enfeksiyon fetüste hasar oluşturmaz.
**E** Enfeksiyon kaynağı esas olarak kontamine süt ürünleridir.

Tahmini cevap **B) IgG avidite testi enfeksiyonun akut mu yoksa geçirilmiş mi olduğunu anlamada önemlidir.**

---

## 27

yeri tahmini cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · İntrauterin Enfeksiyonlar

Gebelikte Toxoplasma gondii enfeksiyonu, tanısı ve korunma önlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Anti-Toxoplasma IgM pozitifliği akut primer enfeksiyon tanısı için her zaman yeterlidir.
B Gebenin kediyle temas etmemesi, çiğ et yememesi korunmada önemlidir.
C IgG avidite testinde yüksek avidite saptanması, enfeksiyonun son 3-4 ay içinde geçirildiğini gösterir.
D Gebeliğin son aylarında fetüse bulaşma riski azalır.
E Konjenital toksoplazmozis riski ilk trimesterde en düşük orandadır.

Tahmini cevap **B) Gebenin kediyle temas etmemesi, çiğ et yememesi korunmada önemlidir.**

## 28

*Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

## 29

cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Kavramlar ve Temel Özellikler

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bir prion hastalığı değildir?

A Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD)
B Kuru
C Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
D Fatal familial insomnia
E Alzheimer hastalığı

Tahmini cevap **E) Alzheimer hastalığı**

> Grupta hatırlanan şıklar: Creutzfeldt-Jakob, kuru, deli dana hastalığı, ailesel ölümcül uykusuzluk.

## 30

*Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

## 31

cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Üriner Sistem Enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A Toplum kaynaklı komplike olmayan ÜSE'de en sık etken E. coli'dir ve çoğunlukla asendan yolla bulaşır.
B Böbreğe ulaşan enfeksiyonlar her zaman hematojen yolla yayılır.
C Semptomsuz olan tüm hastalara antibiyotik başlanmalıdır.
D Üreaz pozitif bakteriler idrar pH'sını asidifiye eder.
E İdrarda tek bir lökosit görülmesi kesin piyelonefrit tanısı koydurur.

Tahmini cevap **A) Toplum kaynaklı komplike olmayan ÜSE'de en sık etken E. coli'dir ve çoğunlukla asendan yolla bulaşır.**

**32**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Üriner Sistem Enfeksiyonları

28 yaşında kadın hasta 2 gündür yanma, ateş, sağ yan ağrısı ile başvuruyor. Fizik muayenede ateş 38,8 °C, sağ KVAH+ saptanıyor. Piyüri ve nitrit pozitif. Piyelonefrit tablosunda doku penetrasyonu yetersizliği nedeniyle tercih edilmeyen antibiyotik hangisidir?

**A** Siprofloksasin
**B** Seftriakson
**C** Fosfomisin (tek doz)
**D** Trimetoprim-sulfametoksazol
**E** Levofloksasin

Tahmini cevap **C) Fosfomisin (tek doz)**

> E şıkkı grupta levofloksasin olarak düzeltildi (iki öğrenci).

---

**33**
cevap doğrulandı

Enfeksiyon Hastalıkları · Bağışıklığı Baskılı Hastalarda Enfeksiyon

Hücresel immün yetmezliği (T lenfosit defekti) olan bir bireyde aşağıdaki fırsatçı mikroorganizmalardan hangisine bağlı enfeksiyon gelişme riski belirgin şekilde artar?

**A** Streptococcus pneumoniae
**B** Haemophilus influenzae
**C** Toxoplasma gondii
**D** Neisseria meningitidis
**E** Streptococcus pyogenes

Tahmini cevap **C) Toxoplasma gondii**

---

**34** *Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

---

**SORU 35–68 · 30/34 TOPLANDI**

# Patoloji

Konular: Patolojiye Giriş · Hücre Hasarı ve Nekroz - I · Hücresel Yaşlanma · Hücresel Adaptasyonlar · Akut Enflamasyon: Vasküler Değişiklikler ve Hücresel Olaylar · Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri · Kronik ve Granülomatöz Enflamasyon · Doku Onarımı ve Yara İyileşmesi · Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama · Tromboz Patofizyolojisi · Emboli, Enfarktüs ve Şok · Aşırı Duyarlılık ve Otoimmünite · Genetik, Pediatrik ve Çevresel Patoloji · Hücre Hasarı ve Nekroz - II · Tümör Biyolojisi ve Terminolojisi · Glomerüler Hastalıklar: Nefrotik Sendrom · Glomerüler Hastalıklar: Nefritik Sendrom · Sistemik Hastalıklarda Böbrek Hasarı · Tübülointerstisyel Hastalıklar · Böbrek Tümörleri · Mesane Hastalıkları ve Tümörleri · Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları · Endometriyal Hiperplazi ve Kanserleri · Over Tümörleri · Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri · Erkek Genital Sistem ve Prostat Hastalıkları

---

**35**
şık eksik

Patoloji · Patolojiye Giriş

Oil Red O ile nötral lipitleri güvenle göstermek için uygun yaklaşım hangisidir?

**A** Doku rutin formalin tespiti sonrası parafine gömülmelidir.
**B** Taze/dondurulmuş (frozen) kesit alınıp tespit işlemi ksilol kullanılmadan yapılmalıdır.
**C** Dokular alkol serilerinden geçirilip dehidrate edilmelidir.
**D** Yüksek ısıda otoklavlanmalıdır.

Tahmini cevap **B) Taze/dondurulmuş (frozen) kesit alınıp tespit işlemi ksilol kullanılmadan yapılmalıdır.**

> Şık eksik: 4 şık toplandı. Grupta "dondurulmuş kesit soru kökünde değil şıktaydı ve cevap oydu", "parafinle ilgili 3 şık ve gümüş boyama vardı" denildi.

**36**
cevap doğrulandı

Patoloji · Hücre Hasarı ve Nekroz - I

Dokularda gelişen nekroz tipleri ve organ eşleşmeleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi en tipik patognomonik/karakteristik eşleşmedir?

A Beyin enfarktı - likefaksiyon nekrozu; Kalp enfarktı - koagülatif nekroz
B Akciğer enfarktı - fibrinoid nekroz; Karaciğer - yağ nekrozu
C Beyin enfarktı - koagülatif nekroz; Dalak - gangrenöz nekroz
D Mide enfarktı - kazeöz nekroz; Böbrek - likefaksiyon nekrozu
E Pankreas - koagülatif nekroz; Beyin - kazeöz nekroz

Tahmini cevap **A) Beyin enfarktı - likefaksiyon nekrozu; Kalp enfarktı - koagülatif nekroz**

---

**37**
şıklar üretildi

Patoloji · Hücresel Yaşlanma

Hücrede ROS artışı kronikleşirse hangi iki süreç öne çıkar?

A Lipit peroksidasyonu ile distrofik kalsifikasyon; protein hasarı ile amiloidoz
B ATP üretiminin artması ile hipertrofi; DNA onarımının artması ile rejenerasyon
C DNA hasarı ile kanser; protein ve lipit hasarı ile hücresel yaşlanma
D Antioksidan artışı ile atrofi; lipit birikimi ile yağlanma
E Katalaz artışı ile apoptoz; süperoksit dismutaz artışı ile nekroz

Tahmini cevap **C) DNA hasarı ile kanser; protein ve lipit hasarı ile hücresel yaşlanma**

> Doğru şık (C) gruptan; diğer şıklar ders notundan üretildi (08 Hücresel yaşlanma: ROS hedefleri lipit, protein ve DNA; sonuç mutasyon ve yaşlanmanın hızlanması); asıl sınav şıkları değildir.

---

**38**
cevap doğrulandı

Patoloji · Hücresel Adaptasyonlar

Patolojik hiperplazi ve neoplazi süreçleri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Hiperplazide uyarı kesilse dahi hücre çoğalması kontrolsüz devam eder.
B Hiperplazi fizyolojik/patolojik uyaranla gelişir; uyarı kesilince büyüme durabilir ancak patolojik hiperplazi neoplaziye zemin hazırlayabilir.
C Neoplazi tamamen geri dönüşümlü bir süreçtir.
D Hiperplazi sadece malign tümörlerde görülür.
E Hiperplazide hücre sayısı sabit kalır.

Tahmini cevap **B) Hiperplazi fizyolojik/patolojik uyaranla gelişir; uyarı kesilince büyüme durabilir ancak patolojik hiperplazi neoplaziye zemin hazırlayabilir.**

---

**39**
cevap doğrulandı

Patoloji · Hücresel Yaşlanma

Kanser hücrelerinde telomeraz enziminin reaktivasyonu ve yüksek aktivitesinin temel patogenetik önemi nedir?

A Hücrenin apoptoza girmesini doğrudan tetikler.
B Hayflick sınırının aşılmasını sağlar, telomer boyunu koruyarak hücreye sonsuz bölünme yeteneği kazandırır.
C DNA replikasyonunu tamamen durdurur.
D Hücre dışı matris yıkımını engeller.
E Tümör hücresinin immün sistem tarafından tanınmasını sağlar.

Tahmini cevap **B) Hayflick sınırının aşılmasını sağlar, telomer boyunu koruyarak hücreye sonsuz bölünme yeteneği kazandırır.**

---

**40**
şıklar üretildi

Patoloji · Akut Enflamasyon: Vasküler Değişiklikler ve Hücresel Olaylar

Fibrinöz perikarditte çözünmeyen (temizlenemeyen) fibrin için beklenen sonuç nedir?

A Organizasyon ile fibrozis ve yapışıklık gelişir
B Apse oluşur
C İz bırakmadan tam rezolüsyon olur
D Ülserasyon gelişir
E Kazeifikasyon nekrozu gelişir

Tahmini cevap **A) Organizasyon ile fibrozis ve yapışıklık gelişir**

> Şıklar ders notundan üretildi (09 Akut enflamasyon: fibrinöz eksüda fibrinolizle çözünür, çözünmezse organizasyon fibrozis ve yapışıklık); asıl sınav şıkları değildir.

---

**41**
şıklar üretildi

Patoloji · Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri

Komplement sisteminin alternatif ve lektin yolu için doğru tetikleyici çifti hangisidir?

A Alternatif: antijen-antikor kompleksi; Lektin: mannoz bağlayıcı lektin
B Alternatif: mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler); Lektin: mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması
C Alternatif: C1 inhibitörü; Lektin: IgM
D Alternatif: mannoz bağlayıcı lektin; Lektin: LPS
E Alternatif: IgG; Lektin: IgE

Tahmini cevap **B) Alternatif: mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler); Lektin: mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması**

> Şıklar ders notundan üretildi (12 Kimyasal mediyatörler, kompleman aktivasyon yolları tablosu); asıl sınav şıkları değildir.

---

**42**
şıklar üretildi

Patoloji · Kronik ve Granülomatöz Enflamasyon

Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri için en doğru kombinasyon hangisidir?

A Ödem + nötrofil infiltrasyonu + tam iyileşme
B Mononükleer hücre infiltrasyonu + doku yıkımı + onarım girişimleri (anjiyogenez, fibrozis)
C Fibrinöz eksüda + nötrofil + apse
D Eozinofil + mast hücresi + vazodilatasyon
E Seröz eksüda + nötrofil + rezolüsyon

Tahmini cevap **B) Mononükleer hücre infiltrasyonu + doku yıkımı + onarım girişimleri (anjiyogenez, fibrozis)**

> Doğru şık gruptan; diğer şıklar ders notundan üretildi (13 Kronik enflamasyon: morfolojik özellikler ve akut-kronik karşılaştırması); asıl sınav şıkları değildir.

---

**43**
şıklar üretildi

Patoloji · Doku Onarımı ve Yara İyileşmesi

Sekonder yara iyileşmesinde en tipik özellik nedir?

A Az skar ve minimal kontraksiyon
B Daha fazla granülasyon dokusu, belirgin skar ve belirgin kontraksiyon
C Kenarları yaklaştırılmış temiz kesi ile iyileşme
D Enfeksiyon riski nedeniyle önce açık bırakılıp sonra kapatılma
E Skarın yara sınırlarının dışına taşması

Tahmini cevap **B) Daha fazla granülasyon dokusu, belirgin skar ve belirgin kontraksiyon**

> Gruptan "az skar..." şıkkı hatırlandı (A, primer iyileşme özelliği). Diğer şıklar ders notundan üretildi (15 Yara iyileşmesi: primer, sekonder, tersiyer iyileşme tablosu); asıl sınav şıkları değildir.

---

**44**
cevap doğrulandı

Patoloji · Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama

Kronik pulmoner konjesyonda en olası histolojik kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A Alveol septasında incelme + lenfatik genişleme
B Alveol septasında fibrozis + hemosiderin makrofajı
C Bronşiolde metaplazi + kazeifikasyon
D Kapiller damarda trombus + koagülasyon nekrozu
E Yaygın amiloid birikim + granülom oluşumu

Tahmini cevap **B) Alveol septasında fibrozis + hemosiderin makrofajı**

---

**45**
şıklar üretildi

Patoloji · Tromboz Patofizyolojisi

Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyel tromboz için Virchow üçlüsünün en uygun bileşenleri hangisidir?

A Staz + laminer akım
B Hiperkoagülabilite + endotel hasarı + staz
C Endotel hasarı + türbülanslı (anormal) kan akımı
D Hiperkoagülabilite + staz
E Laminer akım + hiperkoagülabilite

Tahmini cevap **C) Endotel hasarı + türbülanslı (anormal) kan akımı**

> A ve B gruptan hatırlandı. Diğer şıklar ders notundan üretildi (20 Tromboz: arteriyel trombüste endotel hasarı ön koşul, türbülans örneği ülserleşmiş aterosklerotik plak); asıl sınav şıkları değildir.

---

**46**
cevap doğrulandı

Patoloji · Emboli, Enfarktüs ve Şok

Septik şok seyrinde adrenal yetmezlik gelişmesi hangi sendrom ile ilişkilendirilir?

A Waterhouse-Friderichsen sendromu
B Goodpasture sendromu
C Cushing sendromu
D Conn sendromu
E Addison hastalığı

Tahmini cevap **A) Waterhouse-Friderichsen sendromu**

---

**47**
şık eksik

Patoloji · Aşırı Duyarlılık ve Otoimmünite

Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?

A Dolaşan immün komplekslerin dokularda birikmesiyle gelişir.
B Mast hücreleri ve IgE antikorları aracılığıyla gelişir.
C T lenfositler (CD4+ ve CD8+) aracılıdır, antikorların doğrudan rolü yoktur veya azdır.
D Sadece IgG veya IgM sınıfı antikorlar rol oynar.
E Komplement sisteminin doğrudan aktivasyonu ile saniyeler içinde gelişir.

Tahmini cevap **C) T lenfositler (CD4+ ve CD8+) aracılıdır, antikorların doğrudan rolü yoktur veya azdır.**

> E şıkkı grupta hatırlanmadı. Grupta "lineer IgG iki soruda da şık olarak geçiyordu" denildi.

---

**48**
cevap doğrulandı

Patoloji · Genetik, Pediatrik ve Çevresel Patoloji

Marfan sendromlu hastalarda doku elastik lif yapısındaki bozukluğa bağlı olarak en sık görülen ve hayati tehdit oluşturan kardiyovasküler komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A Pulmoner kapak stenozu
B Mitral kapak kalsifikasyonu
C Triküspit yetmezliği
D Koroner arter aterosklerozu
E Aort anevrizması ve aort diseksiyonu

Tahmini cevap **E) Aort anevrizması ve aort diseksiyonu**

---

**49**
şıklar üretildi

Patoloji · Genetik, Pediatrik ve Çevresel Patoloji

Kurşun maruziyeti olan erişkinlerde en tipik nörolojik bulgu hangisidir?

A Düşük IQ, davranış bozukluğu ve nöbet
B Periferik nöropati; bilek ve ayak düşmesi
C Parkinsonizm ve istemsiz hareketler
D Optik nörit ve görme kaybı
E Ataksi ve nistagmus

Tahmini cevap **B) Periferik nöropati; bilek ve ayak düşmesi**

> Grupta "çocuk ve erişkin bulguları ayrı şıklardaydı" denildi (A çocuk bulgusu). Diğer şıklar ders notundan üretildi (26 Çevresel patoloji: kurşun, sinir sistemi bulguları); asıl sınav şıkları değildir.

---

**50**
yeri tahmini
cevap doğrulandı

Patoloji · Hücre Hasarı ve Nekroz - II

Apoptoz (programlanmış hücre ölümü) mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A Hücre büzülmesi ve kromatin kondansasyonu izlenir.
B Hücre zarı bütünlüğü korunur, belirgin inflamasyon oluşturmaz.
C Ana yürütücü (executioner) kaspaz kaspaz-3'tür; kaspaz-8 ve 9 ise başlatıcıdır.
D DNA 180-200 bp oligonükleozomal fragmanlara bölünür.
E BCL-2 ailesi proteinleri apoptoz regülasyonunda rol almaz.

Tahmini cevap **E) BCL-2 ailesi proteinleri apoptoz regülasyonunda rol almaz.**

---

**51**
cevap doğrulandı

Patoloji · Tümör Biyolojisi ve Terminolojisi

Aşağıdaki klinik tümör kümelenmelerinden hangisi Li-Fraumeni sendromu (TP53 mutasyonu) ile en uyumludur?

A Yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, meme kanseri, beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom
B Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma, paratiroid hiperplazisi
C Kolon polipleri, osteomlar, epidermoid kistler
D Renal hücreli karsinom, hemanjiyoblastom, feokromositoma
E Bilateral akustik nörinom, meningiom, şvannom

Tahmini cevap **A) Yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, meme kanseri, beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom**

---

**52**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Patoloji · Hücre Hasarı ve Nekroz - II

İntrasellüler ROS artışı ve DNA hasarında apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağında gerçekleşen olayların doğru sırası hangisidir?

**A** Sitokrom-c salınımı  BAX/BAK aktivasyonu  Kaspaz-3
**B** BAX/BAK oligomerizasyonu  zar geçirgenlik artışı  sitokrom-c'nin sitozole salınımı  kaspaz aktivasyonu
**C** Kaspaz-3 aktivasyonu  sitokrom-c  DNA kırılması
**D** TNF reseptör bağlanması  kaspaz-8  BAX baskılanması
**E** Bcl-2 artışı  mitokondri patlaması  nekroz

Tahmini cevap **B) BAX/BAK oligomerizasyonu  zar geçirgenlik artışı  sitokrom-c'nin sitozole salınımı  kaspaz aktivasyonu**

---

**53**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Patoloji · Tümör Biyolojisi ve Terminolojisi

Endokrin organ tümörlerinde hormon üretimi ve fonksiyonel aktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

**A** Malign ve anaplastik tümörler her zaman en yüksek hormonu salgılar.
**B** İyi diferansiye benign tümörlerde hormon üretimi ve salgılanması normal endokrin yapıya daha uygundur.
**C** Tümörün diferansiyasyonu düştükçe hormon sentez kapasitesi artar.
**D** Adenomlar hiçbir zaman hormon salgılayamaz.
**E** Hormon üretimi sadece metastatik lezyonlarda gerçekleşir.

Tahmini cevap **B) İyi diferansiye benign tümörlerde hormon üretimi ve salgılanması normal endokrin yapıya daha uygundur.**

---

**54**
cevap doğrulandı

Patoloji · Glomerüler Hastalıklar: Nefrotik Sendrom

Minimal Değişim Hastalığı (Minimal Change Disease) patolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

**A** Proksimal tübülde kresent birikimi
**B** Proksimal tübülde kalsifikasyon birikimi
**C** Proksimal tübülde protein damlacıkları ve lipit birikimi
**D** Proksimal tübülde IgG birikimi
**E** Çizgisel (lineer) IgG birikimi

Tahmini cevap **C) Proksimal tübülde protein damlacıkları ve lipit birikimi**

> Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi; E şıkkı kısmen hatırlandı.

---

**55**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Patoloji · Glomerüler Hastalıklar: Nefritik Sendrom

Aşağıdakilerden hangisi nefritik sendrom klinik tablosunun tipik bulgularından biridir?

**A** Masif proteinüri (>3,5 g/gün) ve belirgin lipidüri
**B** İzole hiperlipidemi ve ksantomlar
**C** İzole glukozüri ve ketonüri
**D** Hematüri, oligüri, hipertansiyon ve eritrosit silendirleri
**E** İzole hipokalsemi ve tetani

Tahmini cevap **D) Hematüri, oligüri, hipertansiyon ve eritrosit silendirleri**

---

## 56

yeri tahmini cevap doğrulandı

Patoloji · Sistemik Hastalıklarda Böbrek Hasarı

Diyabetik nefropatinin patognomonik ve en karakterize histopatolojik nodüler glomerüler nodül bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A Kimmelstiel-Wilson nodülleri
B Libman-Sacks lezyonları
C Flea-bitten böbrek
D Wire-loop lezyonu
E Crescentic glomerülorefleks

Tahmini cevap **A) Kimmelstiel-Wilson nodülleri**

## 57

cevap doğrulandı

Patoloji · Tübülointerstisyel Hastalıklar

Akut piyelonefrit tanısında böbrek histopatolojisinde görülen en tipik mikroskobik bulgu nedir?

A Tübüluslarda ve interstisyel alanda nötrofil lökosit infiltrasyonu ile tübüler nekroz ve lökosit silendirleri
B Glomerüllerde mezanjiyal amiloid birikimi
C Bowman kapsülünde kresent oluşumu
D Arteriyollerde hiyalin kalınlaşma
E İnterstisyel alanda yoğun eozinofil birikimi

Tahmini cevap **A) Tübüluslarda ve interstisyel alanda nötrofil lökosit infiltrasyonu ile tübüler nekroz ve lökosit silendirleri**

## 58

*Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

## 59

cevap doğrulandı

Patoloji · Böbrek Tümörleri

Renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen 3 histolojik/moleküler alt tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A Onkositoma, Wilms, anjiyomiyolipom
B Berrak hücreli (clear cell), papiller, kromofob
C Papiller, Wilms, kromofob
D Berrak hücreli, onkositoma, kromofob
E Kromofob, anjiyomiyolipom, berrak hücreli

Tahmini cevap **B) Berrak hücreli (clear cell), papiller, kromofob**

## 60

cevap doğrulandı

Patoloji · Mesane Hastalıkları ve Tümörleri

Genital Herpes Simplex Virüs (HSV) enfeksiyonunun doku histopatolojisindeki en tipik sitopatolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A Dokuda koilositoz ve belirgin perinükleer halo
B Cowdry A tipi intranükleer inklüzyonlar, multinükleasyon ve nükleer marjinasyon
C Obliteratif/proliferatif endarterit
D Nekrotizan granülom ile oluşan yıldızsı apse
E Lamina propria içinde lenfoid folikül

Tahmini cevap **B) Cowdry A tipi intranükleer inklüzyonlar, multinükleasyon ve nükleer marjinasyon**

## 61

cevap doğrulandı

Patoloji · Vulva, Vajen ve Serviks Hastalıkları

Candida vulvovajiniti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

**A** Tipik olarak kaşıntı ve peynirimsi beyaz akıntı ile seyreder.
**B** Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak sınıflandırılmaz; fırsatçıdır.
**C** Antibiyotik kullanımı ve diyabet riski artırır.
**D** Mikroskopide psödohif ve tomurcuklanan maya hücreleri izlenebilir.
**E** Bulaşması esas olarak siprofloksasin kullanımı ile tamamen engellenir.

Tahmini cevap **E) Bulaşması esas olarak siprofloksasin kullanımı ile tamamen engellenir.**

> Grupta şıklarda hem "cinsel yolla bulaşır" hem "cinsel yolla bulaşmaz" ifadesi olduğu hatırlandı; diğer şıklar kesin değil.

## 62

*Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

## 63

cevap doğrulandı

Patoloji · Endometriyal Hiperplazi ve Kanserleri

Endometriyum hiperplazisini en iyi tanımlayan sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

**A** LSIL / HSIL
**B** Seröz / berrak hücreli
**C** Atipili / atipisiz
**D** Kronik / akut
**E** Papiller / kromofob

Tahmini cevap **C) Atipili / atipisiz**

> Şıklar gruptaki öğrenci sürümünden.

## 64

şıklar üretildi

Patoloji · Over Tümörleri

Bilateral over tutulumu gösteren müsinöz tümörde öncelikle düşünülmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Müsinöz kistadenom
**B** Seröz kistadenom
**C** Krukenberg tümörü
**D** Brenner tümörü
**E** Matür kistik teratom

Tahmini cevap **C) Krukenberg tümörü**

> Grupta yalnız 64. soru için ders slaytı paylaşıldı ("bilateralite önemli ipucu"). Kök ve şıklar ders notundan üretildi (55 Over tümörleri: müsinöz tümörlerin bilateral olma olasılığı düşük; Krukenberg GİS kökenli, sıklıkla bilateral); asıl sınav şıkları değildir.

## 65–66

*Toplanmadı. Bu numaralardaki 2 soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

**67**
şıklar üretildi

Patoloji · Meme Kanseri ve Moleküler Tipleri

Aşağıdakilerden hangisi meme başının Paget hastalığı için doğrudur?

A Olguların tamamına yakınında altta karsinom bulunur ve bunların yaklaşık yarısı invazivdir
B Genellikle bilateraldir
C Prognoz Paget hastalığının varlığına göre belirlenir
D Altta yatan karsinom nadiren bulunur
E Benign bir dermatozdur, malignite ile ilişkisi yoktur

Tahmini cevap **A) Olguların tamamına yakınında altta karsinom bulunur ve bunların yaklaşık yarısı invazivdir**

> Doğru ifade gruptan. Diğer şıklar ders notundan üretildi (65 Meme kanseri: Paget hastalığı unilateral, altta ~%50 invaziv karsinom, prognoz alttaki karsinoma bağlı); asıl sınav şıkları değildir.

**68**
cevap doğrulandı

Patoloji · Erkek Genital Sistem ve Prostat Hastalıkları

Prostat adenokarsinomunu histolojik olarak BPH veya benign bezlerden ayıran en önemli histopatolojik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A Prostat bezlerindeki dış bazal hücre (miyoepitelyal) tabakasının kaybolması
B Bezlerde korpora amilasea bulunması
C Stromada lenfosit birikimi
D Bez boyutlarının aşırı büyümeli olması
E Bezlerin tek katlı silindirik epitelle döşeli olması

Tahmini cevap **A) Prostat bezlerindeki dış bazal hücre (miyoepitelyal) tabakasının kaybolması**

SORU 69–78 · 9/10 TOPLANDI

# Halk Sağlığı

Konular: Bebek Beslenmesi · Halk Sağlığı Tarihçesi · Ana-Çocuk Sağlığı Düzeyinin İzlenmesi

**69**
şıklar üretildi
tartışmalı

Halk Sağlığı · Bebek Beslenmesi

Anne sütü ve bebek beslenmesi ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur?
I. İlk 6 ayda besin gereksiniminin %90'ını karşılar.
II. TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,42'dir.
III. Yalnız anne sütüyle beslenen bebekte demirin emilimi %50-60'tır.
IV. Yeterli beslenen annenin sütü D vitamini dışındaki tüm vitamin ihtiyacını karşılar.

A I ve II
B I ve III
C III ve IV
D II, III ve IV
E I, II, III ve IV

Tahmini cevap **D) II, III ve IV**

> Tartışmalı. Öncüller gruptan (I, II, III kesin; IV "C/D hariç bütün vitaminler" diye hatırlandı), şıklar ders notundan üretildi. 22 Bebek beslenmesi: anne sütü ilk 6 ayda gereksinimin %100'ünü karşılar (I yanlış), demir emilimi %50-60, D vitamini dışındaki vitaminler karşılanır. II ders notunda yok; öğrenciler doğru diye hatırladı.

**70**
yeri tahmini
cevap
doğrulandı

Halk Sağlığı · Halk Sağlığı Tarihçesi

Türkiye'de çağdaş halk sağlığı biliminin kurucusu kabul edilen, 224 Sayılı Sosyalleştirme Kanunu'nu hazırlayan bilim insanı kimdir?

**A** Prof. Dr. Nusret Fişek
**B** Dr. Refik Saydam
**C** Dr. Behçet Uz
**D** Prof. Dr. Mazhar Osman
**E** Dr. Hulusi Behçet

Tahmini cevap **A) Prof. Dr. Nusret Fişek**

---

**71**
yeri tahmini
tartışmalı

Halk Sağlığı · Halk Sağlığı Tarihçesi

Bulaşıcı hastalıkların ve çevresel toplum sağlığı risklerinin önlenmesinde hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetidir?

**A** Besin kontrolü / beslenme değişikliği
**B** Kemoprofilaksi
**C** Bağışıklama
**D** Hijyen
**E** Sağlık eğitimi

Tahmini cevap **D) Hijyen**

> Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi. Cevap tartışmalı: grupta "hijyen mi?" diye soruldu, kesinleşmedi. Bağışıklama ve kemoprofilaksi kişiye yönelik hizmetlerdir.

---

**72**
yeri tahmini
sonradan
eklendi

Halk Sağlığı · Halk Sağlığı Tarihçesi

Aşağıdakilerden hangileri sekonder korunma yöntemidir?
I. Halk sağlığı merkezlerinde verilen hijyen eğitimi
II. Mamografi
III. Bir ailenin çocuklarının ne zaman doğacağını planlaması
IV. Pap smear

**A** Yalnız I
**B** I ve III
**C** II ve IV
**D** Yalnız IV
**E** III ve IV

Tahmini cevap **C) II ve IV**

> Grupta 24.10 eklendi. II. öncülün mamografi mi bağışıklama mı olduğu tartışıldı, çoğunluk mamografi dedi. Kökün "yöntemidir" olduğu hatırlandı.

---

**73**
yeri tahmini
şıklar üretildi

Halk Sağlığı · Halk Sağlığı Tarihçesi

Korunma düzeyleri ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur?
I. İstediği zaman çocuk sahibi olmak için aile planlaması yapan çift tersiyer korunma uygulamaktadır.
II. Okullarda çocuklara yapılan görme taraması ikincil korunmadır.
III. Aşılama birincil korunmadır.
IV. Diyabetik hastada ayak amputasyonunun önlenmesi ikincil korunmadır.

**A** Yalnız II
**B** I ve II
**C** II ve III
**D** III ve IV
**E** I, II ve III

Tahmini cevap **C) II ve III**

> I ve II gruptan hatırlandı; III, IV ve şıklar ders notundan üretildi (18 Halk sağlığı tarihçesi: korunma düzeyleri tablosu); asıl sınav şıkları değildir. Aile planlaması birincil korunmadır (gebelik/doğum komplikasyonlarını önleme).

---

**74**
cevap
doğrulandı

Halk Sağlığı · Bebek Beslenmesi

Terminde ve 2,5 kg doğan bebeğin 6. ay ve 1. yaştaki beklenen ortalama ağırlıkları hangisinde doğru verilmiştir?

**A** 6. ay: 3,5 kg / 1. yaş: 5 kg
**B** 6. ay: 5 kg / 1. yaş: 7,5 kg
**C** 6. ay: 7,5 kg / 1. yaş: 10 kg
**D** 6. ay: 9 kg / 1. yaş: 12 kg
**E** 6. ay: 4 kg / 1. yaş: 6 kg

Tahmini cevap **B) 6. ay: 5 kg / 1. yaş: 7,5 kg**

> Derleme PDF'inin anahtarı C diyor; grupta da paylaşılan ders notuna göre bebekler 4–6 ayda doğum ağırlığının 2, bir yaşında 3 katına ulaşır  B (5 / 7,5 kg).

---

**75**
yeri tahmini
cevap
doğrulandı

Halk Sağlığı · Ana-Çocuk Sağlığı Düzeyinin İzlenmesi

Gebelik takibinde tüm gebelere rutin önerilen ve gebelikte güvenle uygulanabilen aşı aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Kızamıkçık (rubella) aşısı
**B** Suçiçeği aşısı
**C** Tetanoz (Td/Tdap) aşısı
**D** Kızamık aşısı
**E** BCG (verem) aşısı

Tahmini cevap **C) Tetanoz (Td/Tdap) aşısı**

**76**
yeri tahmini
şıklar üretildi

Halk Sağlığı · Ana-Çocuk Sağlığı Düzeyinin İzlenmesi

Güncel Sağlık Bakanlığı rehberine göre sağlıklı bir gebe, gebelik boyunca en az kaç kez izlenmelidir?

A 2
B 4
C 6
D 8
E 13

Tahmini cevap **B) 4**

> Cevap (4) gruptan. Diğer şıklar ders notundan üretildi (23 Ana-çocuk sağlığı: 224 sayılı kanun 13 kez, 2001 yönergesi 6 kez, 2009 ve güncel 4 kez); asıl sınav şıkları değildir.

---

77 *Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

---

**78**
cevap
doğrulandı

Halk Sağlığı · Bebek Beslenmesi

Anne sütünde bulunmayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A Alfa-laktalbümin
B Laktoferrin
C Beta-laktoglobulin
D Sekretuar IgA
E Kazein

Tahmini cevap **C) Beta-laktoglobulin**

---

SORU 79–90 · 11/12 TOPLANDI

# Üroloji

Konular: Üriner Sistem Taş Hastalıkları Fizyopatolojisi · Enürezis Nokturna · Üriner Sistem Enfeksiyonları: Laboratuvar Bulguları ve Tedavi · Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Semptomatolojisi · Üriner Obstrüksiyonun Fizyopatolojisi

**79**
yeri tahmini
cevap
doğrulandı

Üroloji · Üriner Sistem Taş Hastalıkları Fizyopatolojisi

Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taş hastalığı (ürolitiyazis) gelişiminde bir risk faktörü değildir?

A Yetersiz (az) sıvı alımı
B Hiperkalsiüri
C Yüksek oranda hayvansal protein ve tuz tüketimi
D Yeterli su tüketimi
E Sıcak iklimde yaşamak

Tahmini cevap **D) Yeterli su tüketimi**

---

**80**
tartışmalı

Üroloji · Enürezis Nokturna

Enürezis nokturnası olan 7 yaşında erkek çocukta birinci basamak medikal tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Bekle-gör yaklaşımı
**B** Üroterapi
**C** Desmopressin
**D** Antidepresan
**E** Antikolinerjik

Tahmini cevap **C) Desmopressin**

> Kök ve şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi ("davranışsal tedaviye yanıt yok" ifadesi kökte yoktu). Tartışmalı: grubun cevap anahtarlı PDF'i B (üroterapi) diyor; soru "medikal tedavi" sorduğu için C (desmopressin) daha uygun.

---

**81**
cevap doğrulandı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonları: Laboratuvar Bulguları ve Tedavi

Aşağıdaki patolojik durumlardan hangisi prerenal proteinüri (overflow/taşma proteinürisi) nedenleri arasında yer alır?

**A** Glomerülonefrit
**B** Multipl miyelom (Bence-Jones proteinürisi)
**C** Diyabetik nefropati
**D** Polikistik böbrek hastalığı
**E** Alt üriner sistem enfeksiyonu

Tahmini cevap **B) Multipl miyelom (Bence-Jones proteinürisi)**

> Grupta şıklar "gebelik, glomerülonefrit, nefritik sendrom..." diye de hatırlandı; şıklar kesin değil.

---

**82**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Semptomatolojisi

Akut komplike olmayan sistit vakalarında aşağıdaki klinik bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?

**A** Dizüri (idrar yaparken yanma)
**B** Pollaküri (sık idrara çıkma)
**C** Yüksek ateş ve titreme
**D** Sıkışma (urgency) hissi
**E** Suprapubik ağrı

Tahmini cevap **C) Yüksek ateş ve titreme**

---

**83**
yeri tahmini tartışmalı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonları: Laboratuvar Bulguları ve Tedavi

Suprapubik aspirasyon ile elde edilen idrar kültüründe anlamlı enfeksiyon tanısı için en az kaç CFU/mL bakteri yeterlidir?

**A** $10^5$
**B** $10^4$
**C** $10^3$
**D** $10^7$
**E** $10^6$

Tahmini cevap **C) $10^3$**

> Tartışmalı: ders slaytında suprapubik aspirasyonda "herhangi bir sayıda gram(-) basil, $10^3$ gram(+) kok" yazıyor; bir öğrenci "bakteri bulunması anlamlıdır" diye itiraz önerdi. Grubun cevap anahtarlı PDF'i A ($10^5$) diyor; ders slaytına göre C korundu.

---

**84**
yeri tahmini
cevap
doğrulandı

Üroloji · Enürezis Nokturna

Enürezis nokturna için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

**A** 3 yaşın üzerindeki çocuklar tedavi gerektirir.
**B** Yıllık spontan rezolüsyon oranı yaklaşık %15'tir.
**C** Hastalığın patogenezinde genetik de yer alır.
**D** Uyanma güçlüğü sıklıkla eşlik eder.
**E** Enürezis sıklığı arttıkça spontan rezolüsyon oranı azalır.

Tahmini cevap **A) 3 yaşın üzerindeki çocuklar tedavi gerektirir.**

> Grupta 24.10 tamamlandı ve grubun son PDF'inde aynı şıklarla yer aldı; tedavi 5 yaşından sonra düşünülür.

---

**85**
cevap
doğrulandı

Üroloji · Üriner Obstrüksiyonun Fizyopatolojisi

Aşağıdaki obstrüktif üropati nedenlerinden hangisi infravezikal (mesane altı) obstrüksiyon nedenidir?

**A** Renal kist
**B** Posterior üretral valv (PUV)
**C** Gebeliğe bağlı üretere bası
**D** Nefrolitiyazis
**E** Renal arter anevrizması

Tahmini cevap **B) Posterior üretral valv (PUV)**

> Bir öğrenci D şıkkını "fimozis" olarak hatırladı; öyleyse o da infravezikaldir, şıklar kesin değil.

---

**86**
cevap
doğrulandı

Üroloji · Üriner Obstrüksiyonun Fizyopatolojisi

Alt üriner sistem obstrüksiyonlarında mesanenin kompansasyon evresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

**A** Detrüsör kası hipertrofiye uğrar ve işeme basıncını artırarak mesanede rezidüel idrar kalmamasını sağlar.
**B** Mesane kası tamamen atoniktir.
**C** İşeme sonrası yüksek miktarda glob vezikale oluşur.
**D** Böbrek yetmezliği hemen gelişir.
**E** Detrüsör kası incelir ve atrofiye uğrar.

Tahmini cevap **A) Detrüsör kası hipertrofiye uğrar ve işeme basıncını artırarak mesanede rezidüel idrar kalmamasını sağlar.**

---

**87**
cevap
doğrulandı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonları: Laboratuvar Bulguları ve Tedavi

İdrar örneği alma yöntemleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

**A** Orta akım idrarı rutin kültür için en sık kullanılan yöntemdir.
**B** Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık ve güvenilmez idrar alma yöntemidir.
**C** Sondalı hastalarda idrar kateterin özel steril portundan alınmalıdır.
**D** Bebeklerde idrar torbası örneklerinde üremede konfirmasyon gerekebilir.
**E** Suprapubik aspirasyon invaziv bir yöntemdir.

Tahmini cevap **B) Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık ve güvenilmez idrar alma yöntemidir.**

---

**88**
tartışmalı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Semptomatolojisi

Üriner sistem enfeksiyonlarının tanımları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

**A** Rekürren enfeksiyonlar, iyi bir tedavinin ardından genellikle iki haftadan az sürede aynı patojenle gerçekleşen üriner sistem enfeksiyonlarıdır.
**B** Re-enfeksiyon, geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından farklı bir patojenle tekrar enfekte olmaktır.
**C** Bakteriyel persistans, üriner sistemde yerleşmiş patojenlerin yaptığı rekürren enfeksiyonlardır.
**D** Nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyonlar tipik olarak Pseudomonas veya dirençli suşların yaptığı enfeksiyonlardır.
**E** Anatomik ya da yapısal anomalisi bulunmayan hastalardaki üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonu denir.

Tahmini cevap **E) Anatomik ya da yapısal anomalisi bulunmayan hastalardaki üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonu denir.**

> Beş şık gruptaki öğrenci sürümünden. E kesin yanlış (bu tanım komplike olmayan ÜSE'dir). Derleme PDF'i A'yı işaretlemişti; A aslında relapsın tanımıdır, tartışmalı. Grubun cevap anahtarlı PDF'i de A diyor; o sürümde D ve E şıkları (“Tanılar standardize edilmiştir”, “Hiçbiri”) uydurulmuş.

**89**
cevap doğrulandı

Üroloji · Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Semptomatolojisi

Aşağıdakilerden hangisi alt üriner sistemin depolama (dolum) semptom veya fonksiyonlarından biri değildir?

**A** Noktüri
**B** Sıkışma
**C** Aralıklı akım
**D** Pollaküri
**E** Sıkışma tipi idrar kaçırma

Tahmini cevap **C) Aralıklı akım**

**90** *Toplanmadı. Bu numaradaki soru hiçbir kaynakta hatırlanmadı.*

SORU 91–96 · 6/6 TOPLANDI

# Kadın Hastalıkları ve Doğum

Konular: Abortus · Gebelik Terminolojisi ve Kavramları

**91**
cevap doğrulandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Abortus

G2P1 gebede USG'de serviks açık, intrauterin servikse yakın yerleşimli, düzensiz görünümde gestasyonel kese izlenirken embriyo/kalp atımı izlenmiyor. Kanama ve krampları olan bu hastada en olası düşük tanısı nedir?

**A** Abortus imminens (düşük tehdidi)
**B** Komplet abortus
**C** İnkomplet abortus (tam olmayan düşük)
**D** Tekrarlayan gebelik kaybı
**E** Missed abortus

Tahmini cevap **C) İnkomplet abortus (tam olmayan düşük)**

**92**
yeri tahmini
şıklar üretildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Abortus

Spontan düşükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A 2 rad radyasyon maruziyeti düşüğe neden olur.
B Spontan düşüklerin %80'i ilk trimesterde görülür.
C İlk trimester düşüklerinin yaklaşık %50'si kromozom anomalileri ile ilişkilidir.
D Abort materyalinde trizomilerden en sık trizomi 16 görülür.
E Anne yaşı arttıkça kromozomal anomali sıklığı artar.

Tahmini cevap **A) 2 rad radyasyon maruziyeti düşüğe neden olur.**

> A şıkkı gruptan ve kullanıcıdan hatırlandı ("2 birim radyasyon düşüğe neden olur"); cevap A. Bir öğrenci şıklarda "en sık trizomi 21" ifadesinin geçtiğini hatırladı, D bu nedenle şüpheli. Diğer şıklar ders notundan üretildi (61 Abortus: radyasyon >5 rad düşüğe neden olur, düşüklerin %80'i ilk trimester ve %50'si kromozomal, trizomilerden en sık trizomi 16, anne yaşıyla kromozomal anomali artar); asıl sınav şıkları değildir.

---

**93**
cevap
doğrulandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Gebelik Terminolojisi ve Kavramları

Toplam 4 kez gebe kalmış, 36. ve 38. haftalarda 2 canlı çocuk doğurmuş (biri vajinal, biri sezaryen), 16. ve 25. haftalarda 2 kez düşük yapmış kadının G P Y A değeri nedir?

A G4 P2 Y2 A2
B G4 P4 Y2 A0
C G2 P2 Y2 A2
D G4 P3 Y2 A1
E G3 P2 Y1 A1

Tahmini cevap **D) G4 P3 Y2 A1**

> 20. haftayı geçen 25. hafta kaybı doğum (parite) sayılır, 16. hafta kaybı abortus.

---

**94**
cevap
doğrulandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Gebelik Terminolojisi ve Kavramları

Perinatolojide fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki testlerden hangisi bir fetal iyilik hali değerlendirme testi değildir?

A Non-stres test (NST)
B Biyofizik profil (BPP)
C Kontraksiyon stres testi (CST)
D Fetal umbilikal arter Doppler ultrasonografi
E Doppler ile fetal renal arter incelemesi

Tahmini cevap **E) Doppler ile fetal renal arter incelemesi**

> Grupta cevap "Doppler ile renal arter incelemesi" olarak hatırlandı; şıkların geri kalanı kesin değil. Derleme PDF'inde E "maternal serum AFP" idi.

---

**95**
yeri tahmini
sonradan
eklendi

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Gebelik Terminolojisi ve Kavramları

Aşağıdakilerden hangisi gebelikte fetal kromozom anomalilerinin kesin tanısı amacıyla uygulanan invaziv (girişimsel) testlerden biridir?

A İkili tarama testi
B Üçlü tarama testi
C Koryon villus biyopsisi (CVS)
D Entegre tarama testi
E Ultrasonografik ense kalınlığı (NT) ölçümü

Tahmini cevap **C) Koryon villus biyopsisi (CVS)**

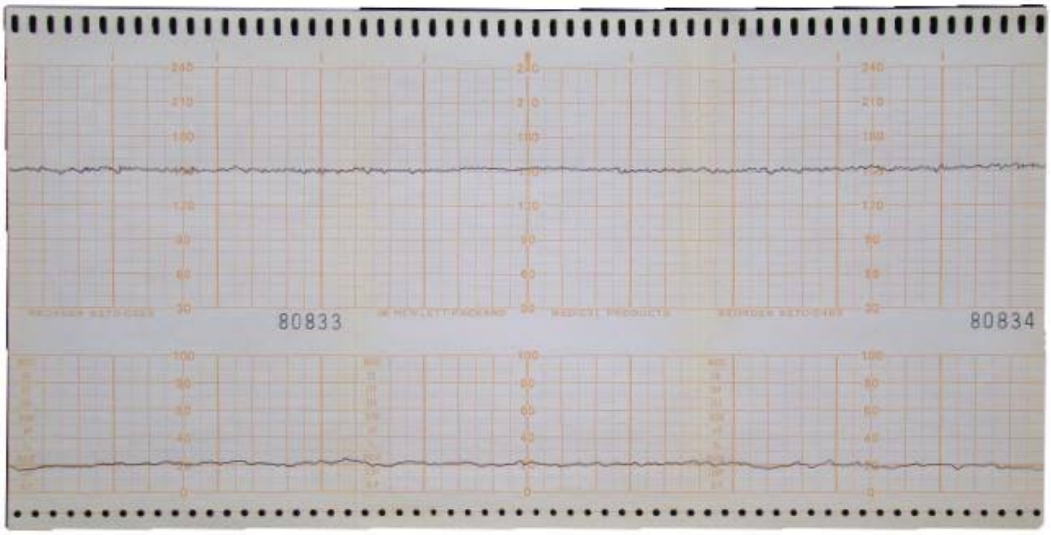
> Grupta 24.10 eklendi. Kökün "biridir" olduğu hatırlandı; dörtlü test şıklarda yoktu, entegre test vardı, CVS ya da kordosentez şıklardaydı.

---

**96**
yeri tahmini
şıklar üretildi
tartışmalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum · Gebelik Terminolojisi ve Kavramları

Gebeliğin 32. haftasından sonra 40 dakikadan uzun süren takipte elde edilen yukarıdaki fetal kalp hızı kaydının (NST trasesi) yorumu aşağıdakilerden hangisidir?




A Reaktif NST
B Non-reaktif NST
C Pozitif kontraksiyon stres testi
D Geç deselerasyon
E Değişken deselerasyon

Tahmini cevap **B) Non-reaktif NST**

> Tartışmalı. Soruda bir KTG trasesi vardı: bazal kalp hızı ~150 atım/dk, değişkenlik çok azalmış, akselerasyon yok, uterin aktivite yok. Grupta cevap için "non stress" denildi ve bu konudaki bir sorunun iptal edildiği konuşuldu. Kök ve şıklar ders notundan üretildi (64 Gebelik terminolojisi: non-reaktif NST = 40 dakikadan uzun takipte yeterli akselerasyon olmaması; non-reaktif trasede akselerasyonsuz, düz görünümlü eğri); asıl sınav şıkları değildir.

SORU 97–100 · 4/4 TOPLANDI

# Farmakoloji

Konular: İmmünofarmakoloji

**97**
cevap
doğrulandı

Farmakoloji · İmmünofarmakoloji

Takrolimusun temel etki mekanizması nedir?

A mTOR proteinini inhibe ederek IL-2 yanıtını engellemek
B Dihidrofolat redüktazı inhibe ederek DNA sentezini bozmak
C Kalsinörini inhibe ederek IL-2 gen transkripsiyonunu engellemek
D IL-2 reseptörünün alfa alt birimini (CD25) bloke etmek
E İnozin monofosfat dehidrojenaz enzimini inhibe etmek

Tahmini cevap **C) Kalsinörini inhibe ederek IL-2 gen transkripsiyonunu engellemek**

> Kök grubun cevap anahtarlı PDF'indeki (24.10 16:31) sürüme göre kısaltıldı (asıl sınava daha yakın); şıklar korundu.

**98**
yeri tahmini cevap doğrulandı

Farmakoloji · İmmünofarmakoloji

Gebelerde kullanımı sırasında ağır teratojenite (fokomeli / ekstremite yokluğu) yol açtığı için gebelikte kullanımı kesinlikle kontrendike olan tarihî ilaç hangisidir?

**A** Talidomid
**B** Penisilin
**C** Parasetamol
**D** Folik asit
**E** İnsülin

Tahmini cevap **A) Talidomid**

---

**99**
cevap doğrulandı

Farmakoloji · İmmünofarmakoloji

SLE nedeniyle uzun süreli hidroksiklorokin (Plaquenil) kullanan bir hastanın organ toksisitesi takibinde rutin olarak hangi muayenenin yapılması gereklidir?

**A** Oftalmolojik (göz dibi / retina) muayene
**B** Odyolojik muayene
**C** Açık akciğer biyopsisi
**D** Kemik iliği aspirasyonu
**E** Günlük troponin ölçümü

Tahmini cevap **A) Oftalmolojik (göz dibi / retina) muayene**

> Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi (birkaçından emin değiller). Soru farmakolojiye aittir (sınavda 99. soru); derleme PDF'leri yanlışlıkla patolojiye koymuştu.

---

**100**
cevap doğrulandı

Farmakoloji · İmmünofarmakoloji

Kemik rezorpsiyonunu engellemek amacıyla kullanılan, RANKL'a karşı geliştirilmiş monoklonal antikor ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

**A** Denosumab
**B** Siklosporin
**C** Metotreksat
**D** İnfliksimab
**E** Bevasizumab

Tahmini cevap **A) Denosumab**

EK 1

# Cevap anahtarı

Harfin rengi durumu gösterir: yeşil doğrulandı, kırmızı tartışmalı ya da şık eksik, mavi sonradan eklendi ya da şıkları üretildi, gri toplanmadı. “metin”: şık yok, cevap soru sayfasında.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | D | D | A | B | A | D | E | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A | C | D | A | C | C | B | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | D | E | C | B | B | B | — | E | — |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | C | C | — | B | A | C | B | B | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| B | B | B | B | C | A | C | E | B | E |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | B | B | C | D | A | A | — | B | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| E | — | C | C | — | — | A | A | D | A |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| D | C | C | B | C | B | — | C | D | C |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | C | C | A | B | A | B | E | C | — |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| C | A | D | E | C | B | C | A | A | A |

EK 2

# Grubun PDF'inde olmayan sorular

Grubun cevap anahtarlı PDF'i (24.10 16:31, 78 soru) ile karşılaştırıldı. Aşağıdaki sorular yalnız bu derlemede var.

| No | Ders | Soru | Dayanak |
|---|---|---|---|
| 37 | Patoloji | Hücrede ROS artışı kronikleşirse hangi iki süreç öne çıkar? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 37 |
| 40 | Patoloji | Fibrinöz perikarditte çözünmeyen (temizlenemeyen) fibrin için beklenen sonuç nedir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 40 |
| 41 | Patoloji | Komplement sisteminin alternatif ve lektin yolu için doğru tetikleyici çifti hangisidir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 41 |
| 42 | Patoloji | Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri için en doğru kombinasyon hangisidir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 42 |
| 43 | Patoloji | Sekonder yara iyileşmesinde en tipik özellik nedir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 43 |
| 45 | Patoloji | Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyel tromboz için Virchow üçlüsünün en uygun bileşenleri hangisidir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 45 |
| 49 | Patoloji | Kurşun maruziyeti olan erişkinlerde en tipik nörolojik bulgu hangisidir? | Patoloji 35–49 listesi (kullanıcı), numara 49 |
| 64 | Patoloji | Bilateral over tutulumu gösteren müsinöz tümörde öncelikle düşünülmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir? | Grupta 64. soru için ders slaytı paylaşıldı |
| 67 | Patoloji | Aşağıdakilerden hangisi meme başının Paget hastalığı için doğrudur? | Grupta 67. soru olarak yazıldı |
| 73 | Halk Sağlığı | Korunma düzeyleri ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur? | Grupta iki öğrenci öncüllerini hatırladı |
| 92 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Spontan düşükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? | Grupta iki öğrenci ifadelerini hatırladı |
| 94 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Perinatolojide fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki testlerden hangisi bir fetal iyilik hali değerlendirme testi değildir? | Grupta 94. soru olarak yazıldı; ilk derleme PDF'inde vardı, son PDF'ten çıkarılmış |
| 95 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Aşağıdakilerden hangisi gebelikte fetal kromozom anomalilerinin kesin tanısı amacıyla uygulanan invaziv (girişimsel) testlerden biridir? | Grupta birkaç öğrenci tartışıp tamamladı |

EK 3

# İstatistikler

“Numarası kesin”: grupta sınavdaki numarasıyla yazılan sorular. “Tam”: kök ve şıklar hatırlandı, cevap tartışmasız. “Grup PDF'inde”: grubun son PDF'inde de yer alan sorular.

| Ders | Sınavda | Toplanan | Numara kesin | Grup PDF'inde | Yalnız bizde | Tam | Şıkları üretilen | Tartış-malı | Toplan-madı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Genetik | 12 | 12 | 5 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Enfeksiyon Hastalıkları | 22 | 19 | 11 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Patoloji | 34 | 30 | 25 | 21 | 9 | 19 | 9 | 0 | 4 |
| Halk Sağlığı | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Üroloji | 12 | 11 | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |

| Ders | Sınavda | Toplanan | Numara kesin | Grup PDF'inde | Yalnız bizde | Tam | Şıkları üretilen | Tartışmalı | Toplanmadı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Farmakoloji | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | **100** | **91** | **57** | **78** | **13** | **67** | **14** | **6** | **9** |